Клинические рекомендации

РСВ-инфекция у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B97.4** — Респираторно-синцитиальный вирус как причина болезней, классифицированных в других рубриках **J00** — Острый назофарингит (насморк) **J02.8** — Острый фарингит, вызванный другими уточненными возбудителями **J04.1** — Острый трахеит **J04.2** — Острый ларинготрахеит **J06.0** — Острый ларингофарингит **J20.5** — Острый бронхит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом **J21.0** — Острый бронхиолит, вызванный респираторным синцитиальным вирусом
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 12.09.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Общественная организация "Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/943_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Этиологическая диагностика 5

3.2 Анализы крови и мочи 5

3.3 Инструментальная диагностика 5

3.4 Консультации 6

3.5 Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции 6

4. Лечение 6

4.1 Противовирусная терапия 6

4.2 Бронхиолит 6

4.3 Симптоматическая терапия 7

4.4 Кислород 7

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7
5.1 Показания к госпитализации 7
5.2 Факторы риска тяжёлого бронхиолита 8
5.3 Профилактика 8
6. Источник и актуальность 8
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Острая вирусная инфекция с умеренной лихорадкой и интоксикацией и частым поражением нижних дыхательных путей: бронхит, бронхиолит, пневмония, бронхиальная обструкция, дыхательная недостаточность.
- С ринитом, особенно при лихорадке, — отоскопия: острый средний отит частый, развивается преимущественно в первые дни. При подозрении на отит или синусит — осмотр оториноларинголога.
- Тяжесть определяет дыхательная недостаточность, а не температура. Сатурация **ниже 92%**, нарастание дыхательной недостаточности или судороги — осмотр реаниматолога.
- Лечение лёгкой и среднетяжёлой формы — как при ОРВИ. При неосложнённом бронхиолите антибиотики, ингаляционные бронхолитики и кортикостероиды рутинно не назначают.
- Бронхиолит, пневмония, дыхательная недостаточность, тяжёлый преморбидный фон — госпитализация в инфекционный стационар с реанимацией.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Острое респираторное вирусное заболевание с катаральным синдромом и преимущественным поражением нижних дыхательных путей, умеренной лихорадкой и интоксикацией; часто бронхит, бронхиолит, пневмония, нередко острая бронхиальная обструкция и дыхательная недостаточность.

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — РНК-вирус семейства Paramyxoviridae, рода Pneumovirus; один серотип, подтипы А и В по тяжести не различаются.

Наибольшие изменения — в бронхах среднего и мелкого калибра, бронхиолах и альвеолах: просвет заполняют слущенный эпителий и экссудат, клапанный механизм задерживает воздух, при полной обструкции — ателектазы. Отёк слизистой мелких бронхов у ребёнка всего **на 1 мм** повышает сопротивление потоку **более чем на 50%**.

Высоко контагиозна; инкубационный период **3–5 дней**, до 8. Путь передачи — воздушно-капельный и контактный. Иммунитет нестойкий: повторно болеют даже в течение одного сезона, реинфекция легче. Вирус выделяется в среднем **10–14 дней**.

Группа риска тяжёлого течения

1. недоношенные с массой тела **2,5 кг и меньше**;
2. бронхолёгочная дисплазия;
3. врождённые пороки сердца;
4. после трансплантации органов, системные и хронические заболевания.

2.3 Классификация

1. по тяжести: лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая;
2. по течению: гладкое, негладкое (осложнённое);
3. по симптомам: типичная, атипичная (бессимптомная);
4. по локализации: ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит, бронхиолит, пневмония и их сочетания.

2.4 Клиническая картина

Начало острое или постепенное, тяжесть нарастает. Температура субфебрильная или нормальная, реже фебрильная; интоксикация умеренная. Катаральные явления умеренные: необильный серозный ринит и фарингит, возможен ларинготрахеит.

У детей **старше 6 лет** и взрослых обычно лёгкое течение с поражением только верхних дыхательных путей.

У детей раннего возраста начинается с ринофарингита, **на 2–3-й день** — бронхит и бронхиолит с бронхиальной обструкцией: экспираторная одышка, втяжение межреберий, приступообразный мучительный кашель.

Аускультация

1. бронхит: на фоне жёсткого дыхания сухие свистящие, у части — влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы;
2. бронхиолит: обильные мелкопузырчатые влажные и крепитирующие хрипы, коробочный звук.

Степени тяжести

Тяжесть	Признаки
лёгкая	температура **не выше 38,5 °C**, интоксикация и катар слабые; нижние дыхательные пути обычно не поражены; чаще дети **старше 3 лет**
среднетяжёлая	**86–90%** случаев, чаще первые годы жизни: ринит, фарингит, ларингит, трахеит, возможен стенозирующий ларинготрахеит; бронхит с обструкцией или бронхиолит, дыхательная недостаточность I–II степени; обратное развитие **через 5–7 дней**
тяжёлая	чаще первый год жизни: вялость, шумное свистящее дыхание, бледность, цианоз, одышка **более 80 в минуту** с участием вспомогательных мышц; обструктивный бронхит, бронхиолит или бронхопневмония с дыхательной недостаточностью II–III; у недоношенных возможна гипотермия

При тяжёлой форме сатурация **ниже 90%**; возможны брадипноэ, апноэ, кардиопульмональная синкопа. Тяжесть поражения нижних дыхательных путей не соответствует выраженности лихорадки: ориентируются на дыхательную недостаточность.

Степени дыхательной недостаточности

Степень	Признаки
I	одышка, тахикардия, раздувание крыльев носа при значительной нагрузке
II	одышка и тахикардия при небольшой нагрузке, небольшой цианоз губ, втяжение межреберий и подреберий
III	одышка и тахипноэ в покое, разлитой цианоз, вспомогательные мышцы; SaO_2 **ниже 90%**, PaO_2 **ниже 60 мм рт. ст.**; возможны гипоксическая энцефалопатия и кардиопульмональная синкопа
IV	гипоксемическая кома: сознания нет, дыхание аритмичное, поверхностное, апноэ

3. Диагностика

Диагноз РСВ-инфекции ставят после этиологической диагностики (ПЦР, иммуноферментный анализ); без неё — синдромальный диагноз. Лабораторная диагностика обычно — при госпитализации или по эпидемическим показаниям.

Основные методы: ОТ-ПЦР на РНК вируса, иммунофлюоресценция и иммунохроматография на вирусные частицы, иммуноферментный анализ на IgM и IgG.

Всем — оценка дыхательной недостаточности: участие вспомогательной мускулатуры, частота дыхания.

3.1 Этиологическая диагностика

При подозрении — однократно ПЦР мазка из носоглотки на РНК РСВ: достоверна на ранних сроках, специфичность и чувствительность 100%.

Для дифференциальной диагностики — ПЦР мазков из носо- и ротоглотки на грипп, парагрипп, риновирусы, аденовирус, коронавирусы, бокавирус, метапневмовирус, SARS-CoV-2: возможна смешанная инфекция.

Если ПЦР невозможна или поздний срок — IgM и IgG к РСВ методом ИФА.

Оценка результата

1. IgM появляются **на 4–5-й день**;
2. диагноз подтверждает и нарастание IgG **в 2–4 раза** в парных сыворотках;
3. однократно выявленные IgG об острой инфекции не говорят;
4. **10–30%** переболевших остаются серонегативными.

Без ПЦР и ИФА — иммунохроматографический экспресс-тест мазка из носоглотки: результат **через 15–30 минут**, чувствительность 75–95%; отрицательный результат подтверждают более чувствительным методом.

Реакция иммунофлюоресценции мазка из носоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

Иммуноцитохимия мазков-соскобов из ротоглотки — если молекулярно-генетическое исследование невозможно.

3.2 Анализы крови и мочи

Среднетяжёлая и тяжёлая форма, длительная лихорадка — развёрнутый общий анализ крови. Для вирусной инфекции типичны лейкопения или нормоцитоз с лимфоцитозом и моноцитозом, но возможны и изменения как при бактериальной.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма — общий анализ мочи: при лихорадке на фоне бронхиолита возможна «токсическая почка» или инфекция мочевых путей.

Подозрение на бактериальную инфекцию и сепсис — С-реактивный белок или прокальцитонин. Посев крови и мочи, СРБ и прокальцитонин — при высокой лихорадке со SpO_2 **ниже 92%** и апноэ; в остальных случаях бактериемия при бронхиолите крайне маловероятна.

3.3 Инструментальная диагностика

Поражение нижних дыхательных путей — пульсоксиметрия: степень тяжести, кислородная поддержка, маршрутизация.

Среднетяжёлое и тяжёлое поражение нижних дыхательных путей — ЭКГ: фоновая патология сердца, подозрение на аритмию, миокардит; SaO_2 **ниже 95%**.

Подозрение на пневмонию — рентгенография грудной клетки: температура **выше 38 °C** **более 3 дней**, токсикоз, укорочение перкуторного звука, асимметрия хрипов.

Рутинная рентгенография при бронхиолите не рекомендуется: ателектазы принимают за пневмонию и необоснованно назначают антибиотики.

Тяжёлое течение, если рентгенографии недостаточно, — КТ органов грудной полости.

3.4 Консультации

Подозрение на отит или синусит — осмотр оториноларинголога. Ринит, особенно с лихорадкой, — отоскопия: острый средний отит частый, ЛОР-осложнения — преимущественно в первые дни, но возможны и позже.

Нарастание дыхательной недостаточности, сатурация **ниже 92%**, судороги — осмотр анестезиолога-реаниматолога для решения о переводе в реанимацию.

3.5 Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции

Дифференциальная диагностика

Диагноз	В пользу диагноза
острый бронхиолит	первый эпизод обструкции **до 2 лет**, сезон вирусов, катар, выраженная одышка, диффузная крепитация и хрипы, слабый ответ на бронхолитики
обструктивный бронхит	обструкция только при простуде, нет атопии у ребёнка и в семье, возможен ответ на бронхолитики
бронхиальная астма	первый эпизод **после 1 года**, аллергены и другие триггеры, атопия, повторные эпизоды и вне простуды, хороший ответ на бронхолитики и ингаляционные ГКС
инородное тело дыхательных путей	внезапное начало во время еды или игры с мелкими предметами, хрипы с одной стороны, нет ответа на бронхолитики
пневмония	лихорадка, влажный кашель, локальные хрипы, притупление, инфильтрат на рентгенограмме, лейкоцитоз, повышение СРБ
муковисцидоз	хроническая инфекция лёгких, кишечные проявления, полипы носа, солёная кожа, отставание в развитии
коклюш	приступообразный кашель с репризами и рвотой, апноэ, нет лихорадки и катара, лимфоцитарный лейкоцитоз

4. Лечение

Лёгкая и среднетяжёлая форма без осложнений — амбулаторно, по общим принципам лечения ОРВИ. Специфической этиотропной терапии нет; лечение начинают с первых симптомов.

4.1 Противовирусная терапия

Дети раннего возраста, в том числе с рождения, с поражением нижних дыхательных путей — интерферон альфа-2b. Эффективнее всего **в первые 3 суток**; при бронхиолите — вспомогательно.

Лекарственные формы интерферона

1. местно: спрей, капли в нос, гель, мазь;
2. системно: свечи.

4.2 Бронхиолит

Неосложнённый бронхиолит — без антибиотиков.

Дегидратация при одышке и поражении нижних дыхательных путей — регидратация.

1. прежде всего перорально;
2. при невозможности — через назогастральный зонд;
3. внутривенно — при эксикозе II–III степени: 0,9% натрия хлорид или натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид), **не более 20 мл/кг/сут** из-за риска отёка лёгких.

Рутинно не применяют при бронхиолите

1. ингаляционные бронхолитики (адреномиметики);
2. ингаляционный будесонид;
3. системные кортикостероиды.

Системные кортикостероиды при бронхиолите — нет убедительных данных об эффективности (УУР B, УДД 2).

Ингаляционный будесонид — нет убедительных данных об эффективности.

4.3 Симптоматическая терапия

Температура **выше 38,5 °C** — парацетамол или ибупрофен по инструкции; при судорогах в анамнезе или на фоне болезни — снижать и при меньшей температуре.

Дети первого года с субфебрилитетом **37,5–38,5 °C**, нарушением самочувствия и сна — гомеопатический Вибуркол, ректальные свечи, по инструкции.

4.4 Кислород

Бронхиолит или дыхательная недостаточность — увлажнённый кислород через носовые канюли или маску при SaO_2 **ниже 92–94%**, до устойчивых **95%**. Тяжёлый бронхиолит, выраженная гипоксия, апноэ — CPAP.

Амбулаторно — местные средства по симптомам: полоскания, тёплое питьё, ингаляции, таблетки для рассасывания, физиотерапия.

Хирургическое лечение не показано.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Госпитализация

1. среднетяжёлая и тяжёлая форма, особенно с осложнениями или обострением сопутствующих болезней у детей первых 2 лет, а у старших — с обострением болезней сердца и лёгких;
2. бронхиолит или пневмония с обструкцией у новорождённых, особенно недоношенных **2,5 кг и меньше**;
3. гемодинамическая нестабильность: холодные конечности, цианоз, мраморность, коллапс, кома;
4. тяжёлый преморбидный фон: пороки лёгких, бронхолёгочная дисплазия, пороки сердца, муковисцидоз, бронхиальная астма, трансплантация.

Чем младше ребёнок, тем шире показания: состояние может ухудшиться катастрофически быстро. Госпитализируют в инфекционный стационар с реанимацией.

Выписка — при стабилизации, купировании дыхательной недостаточности и интоксикации.

5.2 Факторы риска тяжёлого бронхиолита

1. мужской пол;
2. недоношенность, масса при рождении **менее 2500 г**;
3. возраст **до 3–6 месяцев**, масса **менее 5 кг**;
4. врождённая пневмония, аспирация мекония, ИВЛ в неонатальном периоде;
5. скученность, старшие братья и сёстры в детских коллективах, пассивное курение;
6. бронхолёгочная дисплазия, муковисцидоз, пороки дыхательных путей;
7. тяжёлые поражения ЦНС, синдром Дауна, нервно-мышечные болезни, аспирация пищи;
8. пороки сердца с сердечной недостаточностью или лёгочной гипертензией;
9. иммунодефициты.

5.3 Профилактика

Как при ОРВИ: ограничение контактов, маски, мытьё рук; в стационаре — профилактика внутрибольничного заражения. Грудное вскармливание **не менее 6 месяцев** защищает от РСВ.

Паливизумаб — группы риска

1. дети **до 6 месяцев**, рождённые на **35-й неделе** и раньше;
2. дети **до 2 лет**, лечившиеся по поводу бронхолёгочной дисплазии в последние 6 месяцев;
3. дети **до 2 лет** с гемодинамически значимыми пороками сердца.

Дозы — по инструкции.

Специальной реабилитации нет: без поражения мелких бронхов дети восстанавливаются сами; при осложнениях — реабилитация по осложнению.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у детей»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 12.09.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее сентября 2028 года
Код в рубрикаторе	`943_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российская ассоциация специалистов перинатальной медицины; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Инкубационный период указан по-разному: 3–5 (до 8) дней в разделах 1.3 и 1.6, 2–4 дня в комментарии раздела 2.3. Длительность выделения вируса — 10–14 дней (раздел 1.3) и 5–7 дней (раздел 2.3).
- Гомеопатический Вибуркол рекомендован детям первого года (УУР С, УДД 3), тогда как КР «ОРВИ у детей» гомеопатию для лечения ОРВИ не рекомендуют.